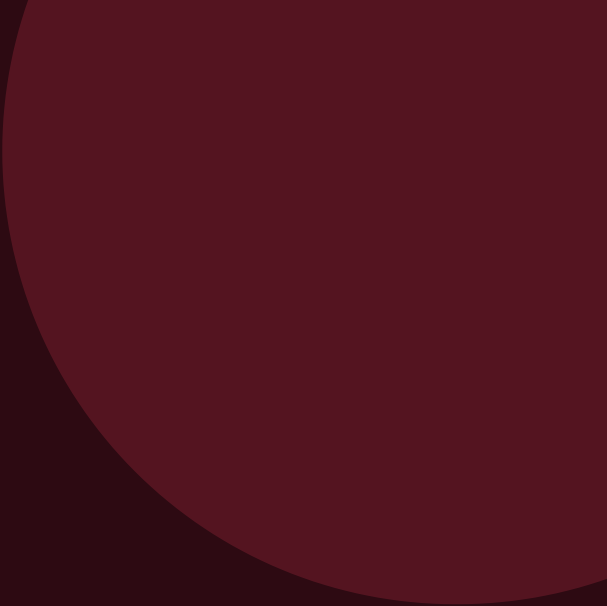




DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 01 DE 12

# O que é DBT e para quem ela funciona

---

A DBT não nasceu de uma teoria em busca de pacientes: nasceu de um fracasso clínico com mulheres cronicamente suicidas — e da decisão de equilibrar mudança com aceitação.

ENCONTRO DE SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2026 · 10H ÀS 12H  
JÚLIO GONÇALVES & ANDRESSA JULIANA

DESCOMPLICANDO A DBT

# Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

**Júlio Gonçalves**



IDEALIZADORA · PROFESSORA

**Andressa Juliana**

## Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

## O ESSENCIAL

- **A DBT nasceu de um fracasso clínico.** A tentativa de tratar mulheres cronicamente suicidas só com estratégias de mudança produzia abandono e sensação de invalidação. A saída foi equilibrar mudança com aceitação.
- **Ela é um tratamento, não uma caixa de técnicas.** Quatro modos e cinco funções sustentam o modelo; aplicar habilidades soltas não é fazer DBT.
- **A evidência mais firme é sobre comportamento autodirigido.** Tentativas de suicídio, autolesão e uso de serviços de crise — não sobre todo e qualquer sofrimento.
- **Nem todo paciente precisa de DBT completa.** O critério é gravidade, risco e multiplicidade de problemas, não simpatia pelo modelo.

## 01 De onde a DBT veio

Marsha Linehan não partiu de uma teoria para depois procurar pacientes. Ela partiu de um grupo específico — mulheres com repetidas tentativas de suicídio e autolesão — e de uma constatação incômoda: a terapia comportamental disponível, focada em mudar o que a pessoa fazia e pensava, era vivida por elas como mais uma voz dizendo que estavam erradas. Muitas abandonavam o tratamento. Outras pioravam.

A resposta não foi abandonar a mudança, e sim colocá-la em tensão com a aceitação. É daí que vem a dialética: duas posições aparentemente incompatíveis — *você está fazendo o melhor que pode* e *você precisa fazer diferente* — sustentadas ao mesmo tempo, sem que uma anule a outra. O primeiro ensaio clínico randomizado saiu em 1991 e comparou a DBT ao tratamento usual da comunidade: o grupo em DBT teve menos episódios de comportamento parassuicida, episódios menos graves do ponto de vista médico, mais permanência na terapia individual e menos dias de internação psiquiátrica.

### Por que isso importa na sua sala

A história de origem não é curiosidade biográfica. Ela explica por que a validação ocupa tanto espaço no modelo: não é gentileza, é condição para que a intervenção de mudança seja tolerável para quem já se sente permanentemente errado.

## 02 Os quatro modos e as cinco funções

A DBT padrão organiza o tratamento em quatro modos semanais, cada um cobrindo uma função que os outros não cobrem sozinhos.

### Terapia individual

Trabalha os alvos por hierarquia, faz análise em cadeia e sustenta o compromisso. Melhora a motivação para mudar.

### Grupo de habilidades

Formato de aula, com tarefas de casa. Aumenta o repertório: mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal.

### Coaching por telefone

Entre sessões, no momento em que a habilidade precisa aparecer. Generaliza o aprendido para a vida real.

### Time de consultoria

Terapia para os terapeutas. Mantém a competência e a motivação de quem atende casos de alto risco.

A quinta função — estruturar o ambiente — atravessa os quatro modos: envolve família, equipe, instituição, tudo o que reforça ou pune o comportamento novo fora da sessão.

## 03 Para quem a evidência sustenta

Ser honesto sobre o alcance do modelo é parte de fazer DBT bem. O corpo de evidência mais sólido diz respeito a **violência autodirigida**: uma metanálise de dezoito ensaios controlados encontrou efeito da DBT sobre comportamento autolesivo e sobre a frequência de recurso a serviços psiquiátricos de crise — mas **não** encontrou efeito significativo sobre ideação suicida isolada. É uma distinção clínica relevante: o modelo muda o que a pessoa faz com a dor antes de mudar a quantidade de dor.

Em adolescentes com autolesão e comportamento suicida repetidos, a versão adaptada (DBT-A) superou o cuidado usual otimizado em ensaio randomizado norueguês, com diferença mantida no seguimento de longo prazo — embora nem todos os desfechos secundários tenham se diferenciado.

### ONDE MODULAR O ENTUSIASMO

As adaptações para transtornos alimentares, uso de substâncias e outras condições existem e são promissoras, mas o volume de ensaios é bem menor do que para TPB e comportamento suicida. Dizer "a DBT funciona para isso" com a mesma firmeza dos dois primeiros domínios é ir além do que os dados sustentam.

## 04 O que a análise de componentes ensinou

Em 2015, o grupo de Linehan comparou três formatos: DBT padrão, treino de habilidades com gerenciamento de caso (sem terapia individual em DBT) e terapia individual em DBT sem o grupo de habilidades. Os três reduziram tentativas de suicídio e autolesão ao longo do ano de tratamento — o que já desfaz a leitura de que só o pacote completo produz efeito. Ainda assim, os formatos que incluíam treino de habilidades levaram vantagem no período agudo, e a DBT padrão se saiu melhor na manutenção dos ganhos.

- **Habilidades importam de verdade.** Não são o "extra pedagógico" do tratamento.
- **Ensinar habilidades não é fazer DBT.** Sem hierarquia de alvos, análise em cadeia e time de consultoria, é outra coisa — legítima, mas outra coisa.
- **Formatos parciais podem ser defensáveis** quando a alternativa realista é não oferecer nada, desde que nomeados com honestidade ao paciente.

## 05 Quem se beneficia na sua clínica

A pergunta prática não é "esse paciente tem TPB?", e sim: há desregulação emocional intensa e persistente, comportamentos que ameaçam a vida ou a terapia, múltiplos problemas simultâneos e histórico de tratamentos que não pegaram? Quanto mais itens, mais o formato completo se justifica.

E há uma distinção que vale carregar pelas doze aulas: **DBT completa** pressupõe os quatro modos e uma equipe. **Prática informada por DBT** é usar princípios e habilidades dentro de outro enquadre. As duas são defensáveis; o que não é defensável é chamar a segunda de primeira — para o paciente, para o convênio ou para si mesmo.

## 06 Referências

- DeCou, C. R., Comtois, K. A., & Landes, S. J. (2019). Dialectical behavior therapy is effective for the treatment of suicidal behavior: A meta-analysis. *Behavior Therapy, 50*(1), 60–72.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press.
- Linehan, M. M., Armstrong, H. E., Suarez, A., Allmon, D., & Heard, H. L. (1991). Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. *Archives of General Psychiatry, 48*(12), 1060–1064.
- Linehan, M. M., Korslund, K. E., Harned, M. S., Gallop, R. J., Lungu, A., Neacsiu, A. D., McDavid, J., Comtois, K. A., & Murray-Gregory, A. M. (2015). Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: A randomized clinical trial and component analysis. *JAMA Psychiatry, 72*(5), 475–482.

- Mehlum, L., Tørmoen, A. J., Ramberg, M., Haga, E., Diep, L. M., Laberg, S., ... Grøholt, B. (2014). Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: A randomized trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 53(10), 1082–1091.
- Mehlum, L., Ramleth, R.-K., Tørmoen, A. J., Haga, E., Diep, L. M., Stanley, B. H., ... Grøholt, B. (2019). Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behavior. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(10), 1112–1122.

#### NOTA DE MÉTODO

Versão preliminar, escrita antes da transcrição do encontro: cobre o escopo previsto na ementa e será substituída pelo resumo fiel à aula. Casos clínicos citados em sala aparecem sempre desidentificados. As referências acima foram conferidas nas fontes originais.

# Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

Escolhi um paciente do meu caso atual para acompanhar ao longo das 12 aulas.

---

Sei dizer, para esse paciente, se o indicado é DBT completa ou prática informada por DBT — e por quê.

---

Mapeei quais dos quatro modos eu tenho hoje disponíveis e quais não tenho.

---

Identifiquei em qual momento da minha prática eu pendo só para mudança ou só para aceitação.

---

Verifiquei se tenho com quem discutir casos de alto risco — e comecei a resolver isso.

---

Minhas anotações — o que levo para a clínica

## Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Por que a validação é condição técnica para a mudança na DBT, e não apenas um cuidado relacional?
02. Que função cada um dos quatro modos cumpre? O que se perde quando um deles falta?
03. A evidência mostra efeito sobre comportamento autolesivo, mas não sobre ideação isolada. Como você explicaria isso a um paciente na primeira sessão?
04. Pense num paciente seu. O que mudaria na condução se você assumisse a hierarquia de alvos da DBT já na próxima sessão?